

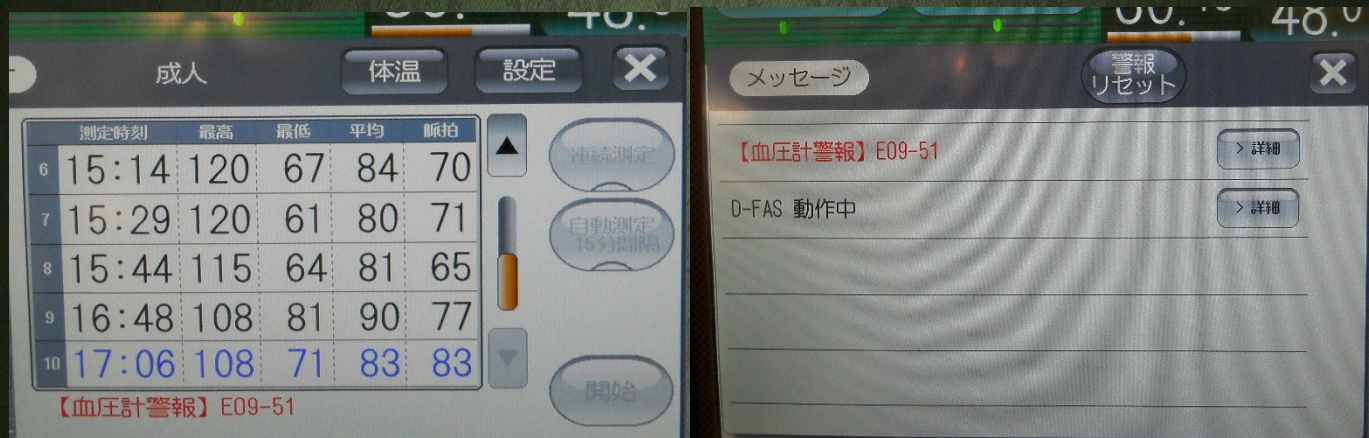
令和7年度 医療機器安全研修

☆もう一度確認しよう！安全透析のための再
チェック

☆コンソールQ&A～よくある疑問を解決～

みたき透析室 重要指名手配

この警報にピンときたら対応！



【血圧計警報】 E09-

51

特徴

- ・体動などにより血圧が測定できなかった時、自動測定タイマーが勝手にOFFになります
- ・高頻度でインシデントを起こす原因になっている凶悪犯です

警報を見つけた方は
血圧を再測定後、
自動測定タイマーを

留意事項

忙しい時の警報はすぐその場を離れたくなりますが
警報を止めた場合必ず、**自分で最後まで対応するか**
他スタッフに依頼してから離れてください

タイマーOFFにより血圧測定されず
血圧低下に気づかなかった場合、最悪の事態を招き

ます

皆さんの協力が必要で す！！！！

インシデント多発中 血圧の再測定忘れ!!

体動で血圧が測れないことが時々ありますが、
もし、**心停止・ショックバイタル・不整脈**な
どで、
血圧が測れていなかった場合、
再測定を忘れてその場を離れても良いと思います
か？

注意

血圧計警報 (E09-51)

再測定 (体動・不整脈)

カフホース点検

測定時間オーバー

脈検出不能

上記以外もあり

必ず立ち止まって

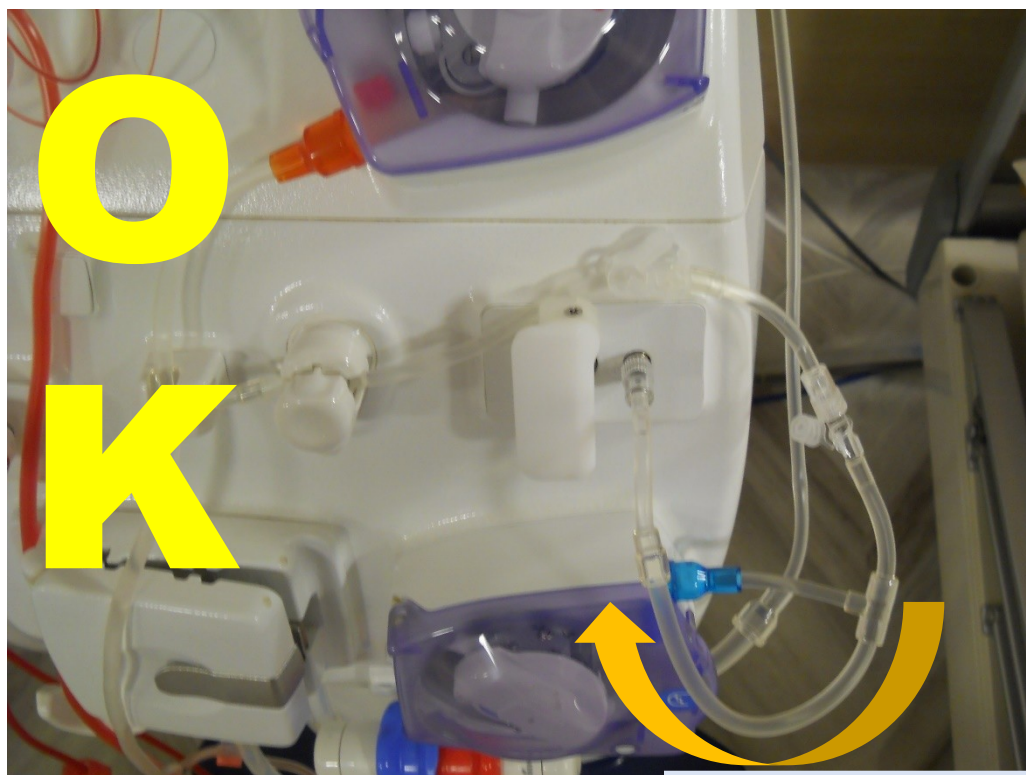
警報確認▶患者状態確認▶

警報解除▶警報に対する対

応

血圧が再測定できるまで
その場を離れないようにしてください

回路折れ曲がりて返血不良が発生しました！



左回りでプライミングポートに
接続してください！！



折れ曲がり

右回りだと
折れ曲がりが発生します

オンラインHDFの
プライミング時注意してください

不明な点はME伊藤まで

重要!

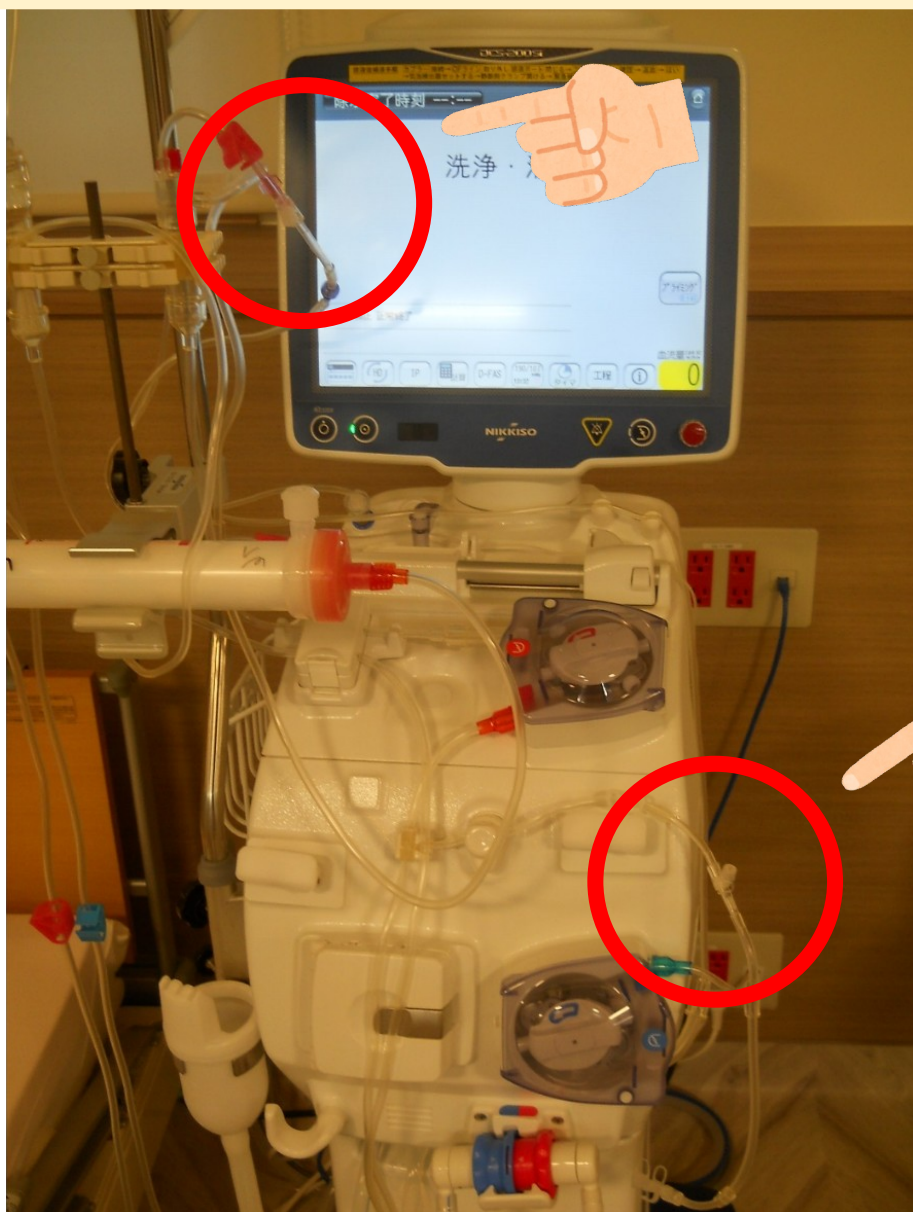
**回路から透析液が漏れ
過除水が発生しました!**

インシデント

オンラインHDFの患者

補液回路の接続部から透析液が少しずつ漏れていた

ロックは締まっていたが押し込みが弱かったためと考えられる
漏れた分が過除水となった

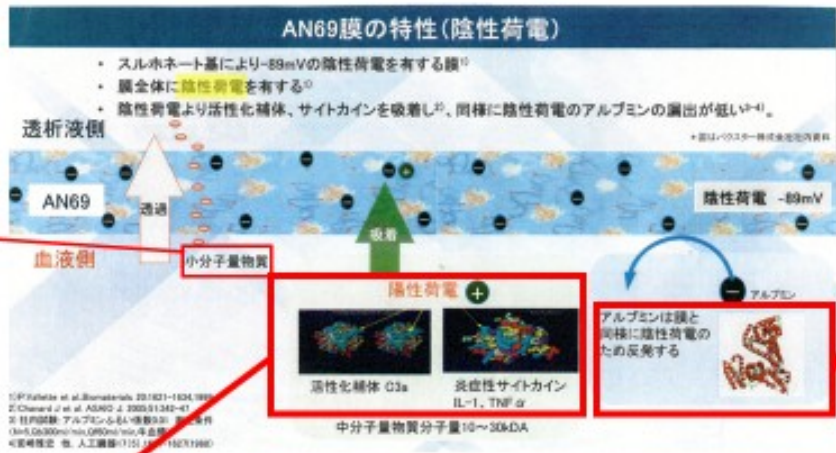


**しっかり押しねじこむ!
しっかり締める!!**

回路からの漏れは
過除水や失血の
大きなリスクです

積層型（AN69膜）の図

積層型の膜は**陰性荷電**（ $\ominus$ になっている）



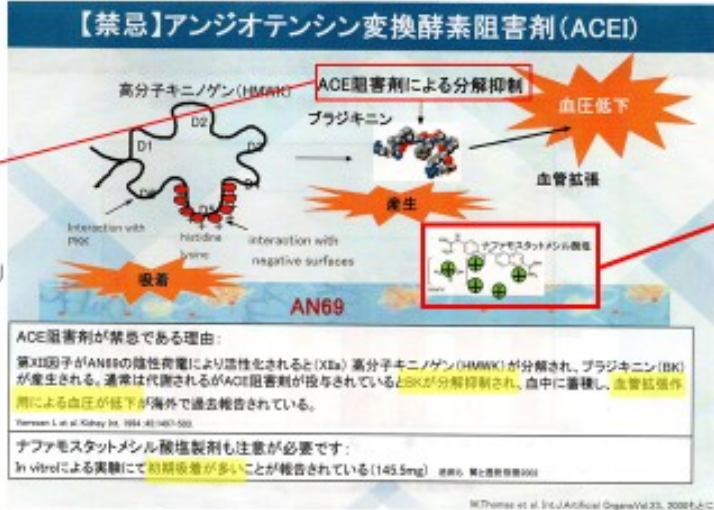
リンやカリウムは問題なく膜を通過し除去される

サイトカインなどの不要物質は $\oplus$ のため膜($\ominus$)が**吸着**してくれる

膜

Albは体内に必要な物質
Albは $\ominus$ のため、膜($\ominus$)と**反発**
→Albが血液から抜けにくい
ためAlb低値の患者に積層型を使用する

積層型と**禁忌**（ナファモスタットとACE阻害薬）



積層を使用するとブラジキニンが産生→本来体内で分解

降圧剤の**ACE阻害薬**には(エースコール等)ブラジキニン分解を抑制効果あり

積層+ACE阻害薬だとブラジキニンが分解されない→ブラジキニンの血管拡張効果により**血圧低下**

ナファモスタットは $\oplus$!!!
積層型の患者に使うと膜($\ominus$)に**吸着**されダイアライザー内にナファモスタットが残り膜がつまる
→いずれダイアライザー内が凝固し**透析継続不能**

逆接続で治療を開始し、シャントチェックの一回目を行った
スタッフも見落とすインシデントが発生しました

「指差し呼称で守る！！いのちと信頼」

☆指差し呼称は自分の確認のためだけではない

もちろん思い込みや見間違いを防ぐという目的が第一です

☆患者さんにも安心を届ける行為

「しっかり確認してくれている」という安心につながります
安全な治療を形で示すことができます

☆仲間にも安全文化を広げる行動

声に出すことで「自分もしっかりやらなきゃ」という意識が広がります

「相手のミスを探す目が患者さんを守る！！」

☆相手を信じすぎない

「間違っているかもしれない」と思って確認しましょう

☆独立して確認する

相手と一緒に見るのではなく自分の目で確かめましょう

☆責任を相手任せにしない

ダブルチェックの人も責任者です

今回のインシデントの患者さんご本人からお声をいただきました。

「声出しをしっかりしているスタッフもいるけど、していないスタッフもいるよ」

みんなで改めて指差呼称、ダブルチェックの大切さを考え、安心安全な
治療を提供していきましょう！！

血液回路をベッドに掛ける際、誤った箇所です鉗子を咬んでしまい、血液回路に亀裂が生じて血液が漏れた事例が発生しました。

鉗子の操作についての説明と注意喚起させていただきます。

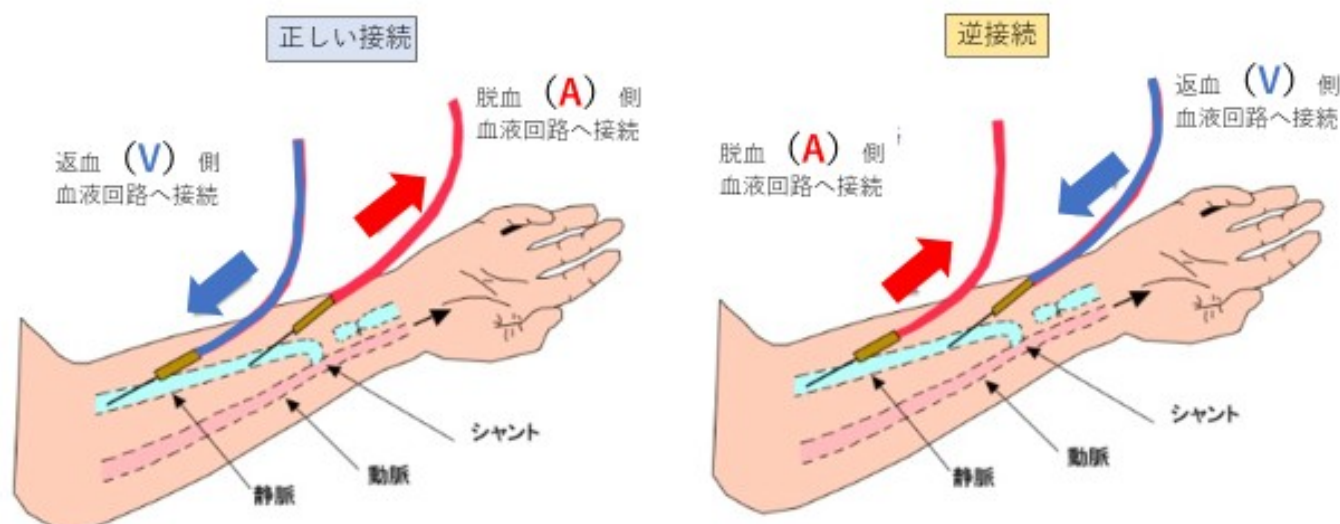
当センターで使用している鉗子は最大3段階はさみ幅を調節できるようになっています。チューブを鉗子で咬む場合は、**2段階**にするようにお願いします。



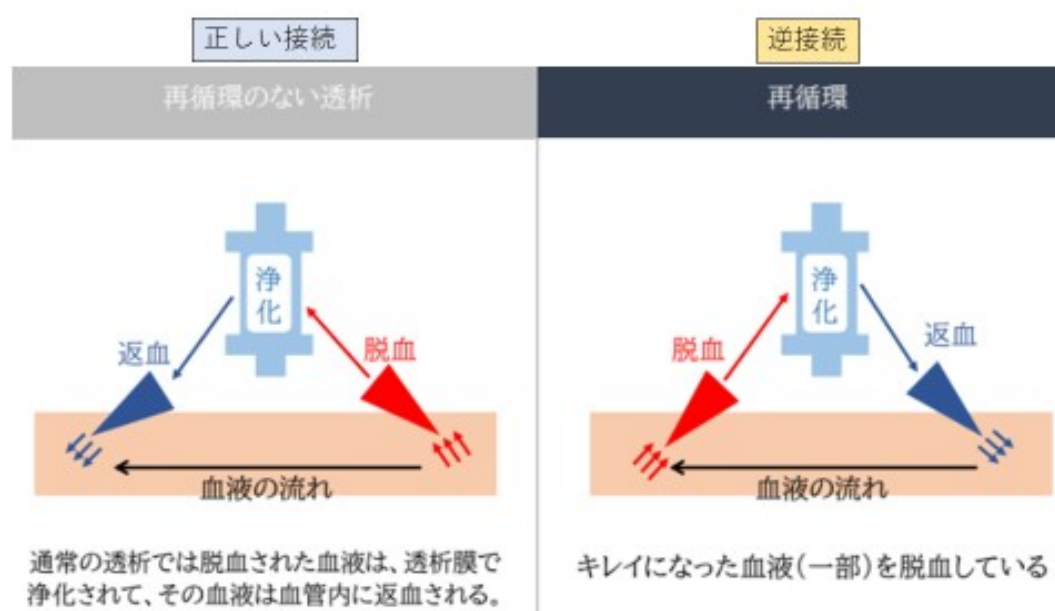
鉗子でチューブを咬む際は、咬む場所の真ん中で咬むようにしてください。



Case1 逆接続



逆接続による再循環

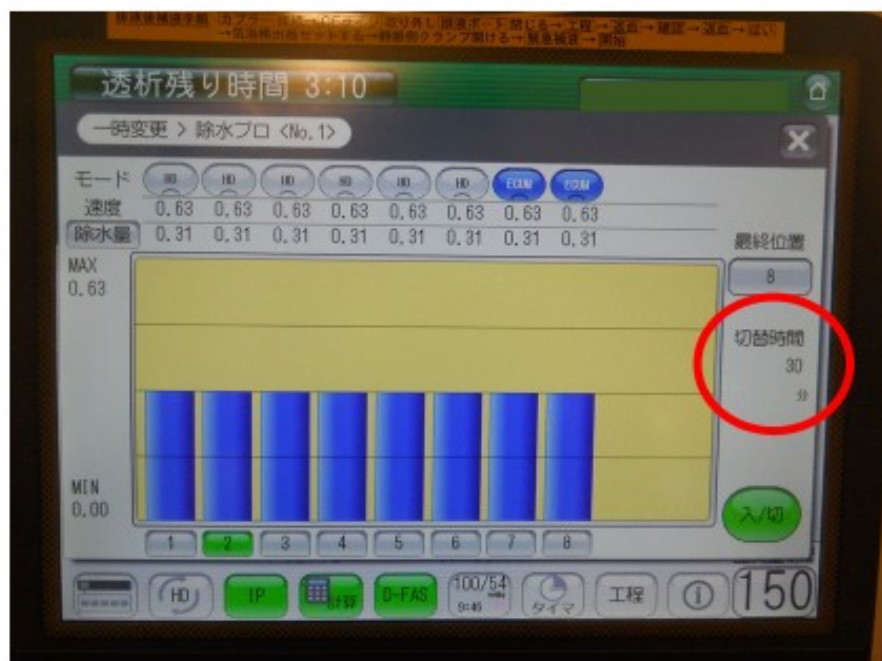
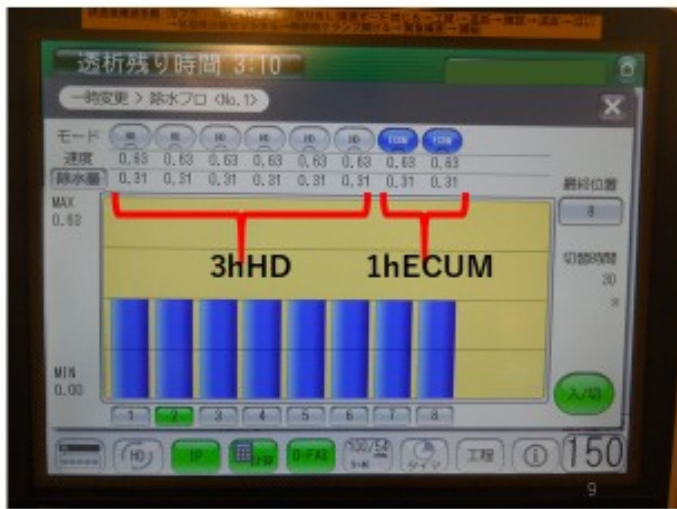


再循環がなぜだめ？

- 透析効率の低下
→ きれいになった同じ血液を再度きれいにしているため
透析効率の低下
- 濃縮による回路凝固
→ 除水して濃くなった血液を再度脱血して
除水しているので、**血液が濃縮され**回路内凝固

Case 2 除水プログラムの切り忘れ

除水プログラムについて



30分に一度
除水速度や
モードの変更が入る

プログラム入

プログラム切



除水速度を0.0L/hrにしたときの注意点

除水速度を0.0L/hrにする（除水をとめる）タイミング

→血圧低下や体調不良時が多い

プログラムが自動変更される時間がきてしまうと

除水が再開されてしまう

除水をとめるべき状況のときに除水が再開されると大事故

→**プログラムをOFFにする**

コンソールのプログラム→「入/切」でOFFにしてください

OFFにすると除水が再開してしまうので

再度、除水速度を0.0L/hrにしてください

プログラムを一度OFFにすると

その透析中はONにすることができません！

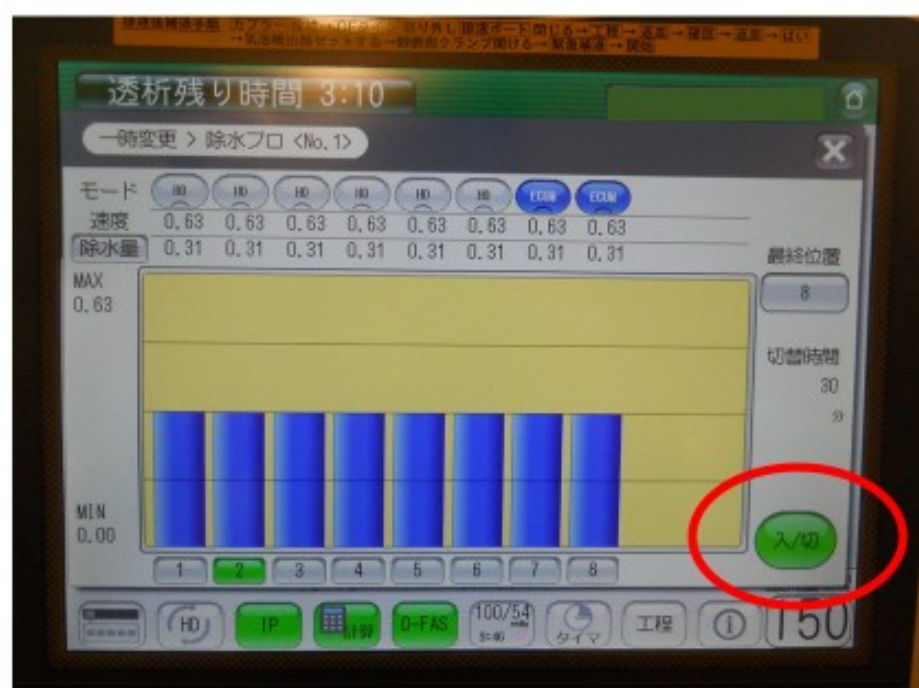
3時間透析+1時間ECUMなどのECUMが入る除水プログラムは

ECUM切り替えタイマーを入れて手動でECUM切り替え、

その他プログラムの場合は医師に相談をしてください

12

13



ここを押して
プログラムをOFFに
してください